MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Requisitos Funcionais e Não Funcionais
Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia

Escopo	Rastreabilidade documental entre entrevistas de levantamento e EOR, com cobertura de requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF).
Base documental	DOC-01 Transcrição da Entrevista 1; DOC-02 Entrevista Marla; DOC-03 EOR do sistema.
Data de elaboração	06/04/2026

Observação metodológica: esta matriz foi construída exclusivamente com base nos três documentos disponibilizados. Referências a questionários ou estudos adicionais citados no EOR foram tratadas apenas como contexto, não como evidência primária de rastreabilidade.

1. Objetivo do documento

Este documento consolida a matriz de rastreabilidade dos requisitos do Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia a partir dos documentos fornecidos. O foco é demonstrar, de forma auditável, como cada requisito funcional (RF) e não funcional (RNF) se conecta às evidências levantadas nas entrevistas e à consolidação formal presente no EOR.

A proposta desta matriz é apoiar validação de escopo, revisão com stakeholders, priorização de backlog e futuras atividades de verificação/validação. Em termos práticos, ela responde a três perguntas: (i) de onde o requisito surgiu, (ii) como ele foi consolidado no EOR e (iii) se a sua formulação é explícita, consolidada ou derivada.

2. Base documental analisada

Código	Documento	Papel na rastreabilidade	Observação
DOC-01	Transcrição da Entrevista 1 - Clínica Espaço Terapêutico	Fonte primária de regras operacionais de clínica multidisciplinar, agenda, finanças, laudos, prontuários e BI.	Documento com maior densidade de regras de negócio.
DOC-02	Entrevista de Levantamento de Requisitos - Marla Gonçalves	Fonte primária do contexto do psicólogo autônomo, uso mobile, self-booking, lembretes e controle financeiro simples.	Documento com maior densidade de requisitos de experiência do usuário.
DOC-03	EOR - Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia	Documento de consolidação formal dos objetivos, RF, RNF e restrições do sistema.	Usado como referência de consolidação, não como única origem dos requisitos.

3. Critérios de classificação da rastreabilidade

- Explícito: o requisito aparece de forma textual ou inequívoca nos insumos (entrevistas) e foi refletido no EOR.
- Consolidado: o requisito foi construído a partir da combinação de evidências, abstração operacional ou resolução de diferenças entre os perfis analisados.
- Derivado: o requisito foi introduzido no EOR para viabilização técnica, regulatória, arquitetural ou de implantação, sem formulação textual direta nas entrevistas.
- Quando havia divergência entre os insumos, a matriz registra a divergência e indica a solução de consolidação adotada no EOR.

4. Síntese executiva da rastreabilidade

- Os requisitos com rastreabilidade mais forte concentram-se em agendamento, lembretes, financeiro, prontuário e laudos, sobretudo com base na Entrevista 1.
- A Entrevista 2 reforça fortemente requisitos de autoagendamento, experiência mobile, rapidez de uso, prova de cancelamento e visão simplificada do financeiro.
- Os RNF de segurança, criptografia, backup, compatibilidade e desempenho possuem maior peso de derivação técnica/regulatória dentro do EOR.
- Há três divergências relevantes que exigem validação com stakeholders: política de cancelamento, grau de automação do financeiro e complexidade de multiusuário/acesso compartilhado.

5. Divergências relevantes identificadas

Tema	Achado	Diretriz de consolidação
Política de cancelamento	DOC-01: cobrança automática com menos de 24h. DOC-02: cobrança de 50% com menos de 4h, salvo emergência.	Manter regra parametrizável por clínica/profissional e exigir registro com timestamp.
Automação financeira	DOC-01 deseja geração de cobrança e link de pagamento. DOC-02 prioriza apenas controle de quem pagou e quem deve.	Tratar o financeiro em níveis modulares: controle simples obrigatório e cobrança automatizada configurável.
Multiusuário / compartilhamento	DOC-01 requer visão multiprofissional desde o início. DOC-02 não precisa agora, mas vê valor futuro.	Modelar RBAC desde a primeira versão, com modos de operação independentes e compartilhados.
Canais de comunicação	DOC-01 menciona WhatsApp, e-mail e Instagram. DOC-02 prioriza WhatsApp/e-mail.	Priorizar WhatsApp e e-mail no MVP e tratar Instagram como integração evolutiva.

6. Matriz de rastreabilidade dos requisitos funcionais

As tabelas a seguir relacionam cada requisito funcional do EOR com sua origem documental principal e com a forma de consolidação adotada. A coluna “Consolidação no EOR” indica o vínculo mais relevante com objetivos, restrições ou problemas catalogados no próprio EOR.

5.1 Módulo de Cadastro

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-01	Alta	Permitir cadastro de paciente com nome completo, data de nascimento, telefone, e-mail, responsável (quando aplicável), plano e origem/indicação.	DOC-02: Marla define como dados essenciais nome, nascimento, telefone, e-mail, origem/indicação e plano; DOC-01: fluxo clínico envolve responsáveis e pacientes.	OBJ-01, OBJ-05; RF-01	Consolidado - requisito nasce explicitamente da entrevista da psicóloga e é ampliado pelo contexto da clínica.
RF-02	Alta	Permitir cadastro de responsável legal para pacientes menores de idade, com identificação e contato.	DOC-01: presença das mães/responsáveis é central no agendamento, assinatura de presença e cobrança; DOC-02: menção ao responsável quando menor é coerente com o cadastro.	OBJ-05; RF-02	Consolidado - fortemente sustentado pelo fluxo da clínica com responsáveis.
RF-03	Alta	Cadastrar profissionais com registro, especialidade, disponibilidade e associação a salas.	DOC-01: equipe multidisciplinar, conflito de agenda com outros vínculos e necessidade de controlar disponibilidade do colaborador.	P03; OBJ-01; RF-03	Explícito - decorre diretamente do problema operacional relatado pela clínica.
RF-04	Alta	Cadastrar salas/consultórios com identificação, tipo e horários disponíveis.	DOC-01: infraestrutura com 2 consultórios e 1 sala multi; regra obrigatória de controlar ocupação da sala física.	P03; OBJ-01; RF-04	Explícito - necessidade operacional textual na Entrevista 1.

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-05	Média	Cadastrar planos e pacotes de atendimento associáveis aos pacientes.	DOC-01: tratamentos contínuos possuem entrada no início e acerto ao final; DOC-02: valores variam conforme paciente; não há menção literal a “pacotes”, mas há lógica recorrente de tratamento.	P04; OBJ-03; RF-05	Derivado - formaliza comercialmente um fluxo contínuo já presente nos insumos.

5.2 Módulo de Agendamento

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-06	Alta	Validar simultaneamente disponibilidade de profissional, sala e horário ao criar agendamento.	DOC-01: dificuldade de conciliar horário da mãe, agenda do colaborador e ocupação da sala; DOC-02: agenda varia por dia e sessão tem duração definida.	P03; OBJ-01; RF-06	Explícito - problema operacional central da clínica.
RF-07	Alta	Permitir que a secretaria crie, edite e cancele agendamentos em nome do paciente.	DOC-01: agendamento é 100% manual e consome tempo da equipe/secretaria.	P01; OBJ-01; RF-07	Explícito - espelha o modo atual de operação.
RF-08	Média	Disponibilizar autoagendamento por link público, sem dependência de contato humano.	DOC-02: self-booking por link é um dos três principais fatores de adoção; DOC-01: sistema está autorizado a criar agendamentos.	P09; OBJ-06; RF-08	Explícito - necessidade textual da entrevistada Marla.
RF-09	Alta	Suportar agendamentos recorrentes com edição individual ou em lote.	DOC-01: avaliações e intervenções devem ficar agendadas até o fim do tratamento.	OBJ-01; RF-09	Explícito - recorrência aparece expressamente na Entrevista 1.

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-10	Média	Permitir agendamento multidisciplinar sequencial para o mesmo paciente no mesmo dia.	DOC-01: sistema deve priorizar sessões sequenciais entre especialidades para facilitar a logística dos responsáveis.	OBJ-01; RF-10	Explícito - requisito específico de clínica multidisciplinar.
RF-11	Alta	Bloquear agendamentos em feriados e datas configuradas como não úteis.	DOC-01: não há atendimento em feriados.	RF-11	Explícito - regra de negócio direta.
RF-12	Média	Permitir cancelamento ou redistribuição da sessão em caso de ausência do profissional, com notificação automática.	DOC-01: em falta do profissional, o sistema cancela e reagenda, com intervenção humana para comunicar.	RF-12	Consolidado - regra de negócio explícita complementada por automação de notificação.
RF-13	Alta	Registrar cancelamentos com data e hora exatas para suportar política de cancelamento tardio.	DOC-02: Marla relata dificuldade em provar o horário do cancelamento; precisa de evidência objetiva.	P08; OBJ-07; RF-13	Explícito - dor claramente verbalizada pela usuária.

5.3 Módulo de Lembretes e Comunicação

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-14	Alta	Enviar lembretes automáticos de consulta por WhatsApp e/ou e-mail, com antecedência mínima definida.	DOC-01: sistema pode enviar lembretes; DOC-02: lembrete automático é um diferencial de adoção e ajuda a reduzir faltas.	P02; OBJ-02; RF-14	Explícito - sustentado pelas duas entrevistas.

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-15	Alta	Enviar confirmação imediata após criação ou confirmação do agendamento.	DOC-02: fluxo atual depende de confirmar por mensagem; DOC-01: criação de agendamentos e comunicação fazem parte do escopo do sistema.	OBJ-01, OBJ-02; RF-15	Consolidado - naturaliza no sistema um passo hoje manual.
RF-16	Alta	Notificar automaticamente o paciente sobre cancelamento ou alteração de consulta.	DOC-01: em falta do profissional há necessidade de comunicar; DOC-02: cancelamentos tardios geram fricção operacional.	OBJ-02; RF-16	Consolidado - exigência derivada diretamente do fluxo de reagendamento.
RF-17	Baixa	Enviar follow-up pós-consulta para feedback ou orientações.	DOC-01: escopo autorizado do agente inclui follow-up pós-consulta e coleta de feedback.	RF-17	Explícito - funcionalidade descrita no escopo do agente.
RF-18	Baixa	Responder dúvidas frequentes de pacientes sobre horários, endereço e serviços.	DOC-01: agente pode responder dúvidas frequentes e fornecer informações sobre serviços.	RF-18	Explícito - requisito textual no escopo do agente.
RF-19	Média	Encaminhar o atendimento para um humano quando a automação não resolver a demanda.	DOC-01: encaminhamento para humano é autorizado quando necessário.	RF-19	Explícito - limite operacional da automação já definido.

5.4 Módulo de Controle de Presença

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-20	Alta	Registrar presença por sessão com assinatura digital ou confirmação do responsável.	DOC-01: necessidade de lançar automaticamente quem foi e quem não foi; assinatura do controle de horas é feita presencialmente pelas mães.	OBJ-04; RF-20	Explícito - regra operacional direta.
RF-21	Alta	Gerar listagem de presença por sessão com paciente/responsável, data, hora e profissional.	DOC-01: controle de horas de atendimento e validação por assinatura; necessidade de estatísticas e comprovação operacional.	OBJ-08; RF-21	Consolidado - sistematiza um controle hoje físico/manual.
RF-22	Média	Controlar histórico de faltas, distinguindo ausências com e sem aviso.	DOC-01: necessidade de saber quem foi e quem não foi; DOC-02: ocorrência recorrente de faltas e cancelamentos tardios.	P02; RF-22	Consolidado - une a dor de faltas à necessidade de registro operacional.
RF-23	Média	Emitir relatório de frequência por paciente e período, com percentual de presença e ausências.	DOC-01: interesse em estatísticas de evolução por etapa e profissional; controle de presença é insumo para indicadores.	P07; OBJ-08; RF-23	Consolidado - requisito analítico construído a partir do controle de presença.

5.5 Módulo Financeiro

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-24	Alta	Gerar cobrança automaticamente após confirmação do agendamento ou consumo de sessão/pacote.	DOC-01: agente pode emitir cobranças automáticas e gerar relatórios financeiros; fluxo financeiro está acoplado ao atendimento.	P04; OBJ-03; RF-24	Explícito - necessidade textual da clínica.
RF-25	Alta	Enviar link de pagamento por Pix ou cartão ao paciente/responsável.	DOC-01: sistema pode gerar links de pagamento; métodos aceitos incluem cartão, transferência e Pix.	OBJ-03, OBJ-10; RF-25	Explícito - requisito textual da Entrevista 1.
RF-26	Alta	Registrar pagamentos recebidos com data, valor, método e vínculo à sessão.	DOC-01: equipe alimenta manualmente o consultorio.me quando o pagamento é parcelado; DOC-02: usuária quer saber quem pagou e quanto pagou.	P04; OBJ-03; RF-26	Explícito - forte lastro nas duas entrevistas.
RF-27	Alta	Identificar inadimplência e notificar a secretaria sem bloquear automaticamente novos agendamentos.	DOC-01: cobrança é manual; sistema não deve impedir novos agendamentos automaticamente, mas não deve deixar de cobrar; DOC-02: diferencial é saber quem está devendo.	P04; REST-03; RF-27	Explícito - regra de negócio claramente definida.
RF-28	Alta	Gerar recibo digital após confirmação de pagamento, apto a reembolso.	DOC-01: necessidade de automatizar emissão de recibos; clínica emite recibo para reembolso.	P05; RF-28	Explícito - necessidade textual da clínica.
RF-29	Alta	Bloquear liberação de laudos e relatórios clínicos enquanto houver pendência financeira.	DOC-01: regra estrita de não entregar laudos sem fechar o pagamento.	P06; REST-04; RF-29	Explícito - regra crítica de negócio.

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-30	Média	Controlar saldo e vencimento de pacotes/sessões, notificando proximidade de esgotamento.	DOC-01: tratamentos contínuos com acerto financeiro ao longo do processo; necessidade de gestão recorrente; a noção de “saldo de pacote” não aparece literalmente.	OBJ-03; RF-30	Derivado - formalização de um fluxo contínuo de tratamento e cobrança.
RF-31	Média	Aplicar taxa de cancelamento tardio conforme política configurável da clínica/profissional.	DOC-01: cancelamento com menos de 24h deve ser cobrado automaticamente; DOC-02: regra pretendida é cobrar 50% se houver menos de 4h, salvo emergência.	P08; OBJ-07; RF-31	Consolidado - há divergência de janela e percentual; o EOR resolve corretamente via parametrização.
RF-32	Média	Gerar relatórios financeiros por período, inadimplência, modalidade de pagamento e status das sessões.	DOC-01: necessidade de relatórios financeiros e estatísticas da empresa; DOC-02: deseja “resuminho no fim do mês”.	OBJ-08; RF-32	Explícito - sustentado pelas duas entrevistas.
RF-33	Média	Permitir tarifas diferenciadas por paciente, profissional ou serviço.	DOC-01: clínica trabalha com descontos; DOC-02: atende pacientes com tarifa social, com valores variados.	RF-33	Explícito - regra comercial explicitada pelos usuários.

5.6 Módulo de Prontuário Eletrônico

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-34	Alta	Criar prontuário eletrônico vinculado ao cadastro do paciente.	DOC-01: desejo de ter prontuários prontos, para o profissional apenas alimentar os dados.	OBJ-04; RF-34	Explícito - demanda direta da clínica.

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-35	Alta	Disponibilizar modelos de prontuário por especialidade e tipo de atendimento.	DOC-01: necessidade de modelos prontos; menciona laudos de TDAH e prontuário inteligente.	P10; OBJ-04; RF-35	Explícito - detalhamento direto do prontuário inteligente.
RF-36	Alta	Registrar evolução clínica ao final de cada sessão, com vínculo a data e profissional.	DOC-01: necessidade de verificar estatísticas e evolução das etapas do tratamento; profissionais devem alimentar dados clínicos.	P07; OBJ-04; RF-36	Consolidado - abstrai em registro por sessão a necessidade de acompanhar evolução.
RF-37	Média	Permitir acesso multiprofissional ao prontuário conforme permissões.	DOC-01: vários profissionais podem acessar o mesmo paciente para visão multidisciplinar; DOC-02: múltiplos usuários seriam úteis futuramente.	OBJ-05; RF-37	Explícito - forte aderência ao contexto da clínica e visão de evolução futura.
RF-38	Alta	Oferecer anamnese digital para preenchimento antes ou durante a primeira sessão.	Não há menção literal nas entrevistas; decorre da necessidade de padronização do prontuário e do conceito de ficha inicial presente no EOR.	OBJ-04; RF-38; Glossário/Introdução	Derivado - requisito de estrutura clínica inserido pelo EOR para completar o fluxo assistencial.
RF-39	Alta	Gerar laudos e relatórios clínicos a partir dos dados do prontuário, com etapa prévia de revisão.	DOC-01: laudos hoje são manuais e precisam de correção; há necessidade de converter dados em estatísticas e controlar liberação.	P06, P10; RF-39	Explícito - necessidade textual da clínica.
RF-40	Média	Permitir envio do laudo ao paciente/responsável após aprovação do profissional.	DOC-01: laudo só pode ser entregue após pagamento; sistema deve apoiar a entrega controlada.	REST-04; RF-40	Consolidado - operacionaliza a etapa final do fluxo de laudo.

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-41	Média	Acompanhar a etapa atual do tratamento de cada paciente.	DOC-01: necessidade de verificar estatísticas e evolução das etapas do tratamento.	P07; RF-41	Explícito - necessidade textual da clínica.

5.7 Módulo de Relatórios e Indicadores

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-42	Média	Exibir painel de indicadores operacionais com volume de consultas, cancelamentos, faltas, serviços demandados e desempenho por profissional.	DOC-01: métricas e BI detalhados sobre atendimentos, cancelamentos, pedidos, serviços mais solicitados, profissionais e ocorrências.	OBJ-08; RF-42	Explícito - necessidade analítica explícita.
RF-43	Média	Gerar relatório de atendimentos por período, profissional, tipo de serviço e status.	DOC-01: necessidade de estatísticas e controle operacional; relatórios gerenciais fazem parte da visão da gestora.	OBJ-08; RF-43	Consolidado - detalha operacionalmente o pedido de BI.
RF-44	Baixa	Produzir estatísticas clínicas agregadas e anonimizadas sobre diagnósticos e laudos.	DOC-01: necessidade de converter laudos manuais em estatísticas; o atributo de anonimização deriva da preocupação com dados sensíveis.	OBJ-08, OBJ-09; RF-44	Consolidado - evidência funcional existe; anonimização entra por requisito regulatório.
RF-45	Média	Exportar relatórios em PDF e CSV.	Não aparece literalmente nas entrevistas; deriva da necessidade de relatórios gerenciais, intercâmbio e operação administrativa.	OBJ-08; RF-45	Derivado - convenção de produto para tornar o relatório utilizável fora do sistema.

5.8 Módulo de Controle de Acesso

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-46	Alta	Exigir autenticação para usuários internos (administrador, secretaria e profissionais).	DOC-01: prontuários e dados financeiros são sensíveis e compartilhados entre profissionais; a necessidade de segurança é implícita, não textual.	OBJ-05, OBJ-09; RNF-04; RF-46	Derivado - requisito técnico indispensável para suportar LGPD e controle de acesso.
RF-47	Alta	Implementar perfis de acesso distintos para administrador, secretaria, profissional e paciente/responsável.	DOC-01: atores distintos no fluxo (gestora, secretária, profissionais, mães/responsáveis); DOC-03 detalha explicitamente os perfis de usuário.	OBJ-05; RF-47; seção 3.2	Consolidado - deriva do mapeamento de stakeholders e usuários.
RF-48	Média	Manter log das ações relevantes realizadas por cada usuário.	DOC-02: necessidade de provar horário de cancelamento; DOC-01: importância de rastrear presença, laudos e ocorrências.	OBJ-09; RNF-09; RF-48	Consolidado - requisito funcional que materializa a rastreabilidade operacional.

5.9 Módulo de Integrações

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-49	Média	Sincronizar agenda com Google Calendar de forma bidirecional.	DOC-01: integração com calendário e Google Calendar é explicitamente desejada; DOC-02 usa Google Agenda no fluxo atual.	OBJ-10; RF-49	Explícito - sustentado pelos dois contextos de uso.

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RF-50	Alta	Integrar com gateway de pagamento para Pix, cartão e demais meios aceitos pela clínica.	DOC-01: integração com sistema de pagamento/cartão; métodos aceitos incluem cartão, transferência e Pix.	OBJ-10; RF-50	Explícito - requisito textual da Entrevista 1.
RF-51	Alta	Integrar comunicação automatizada com WhatsApp.	DOC-01: comunicação por WhatsApp, Instagram e e-mail; DOC-02: WhatsApp é o principal canal atual com pacientes.	OBJ-02, OBJ-10; RF-51	Explícito - canal predominante e central no contexto dos usuários.
RF-52	Baixa	Importar dados básicos a partir de planilhas CSV/XLSX para facilitar a migração inicial.	DOC-01: clínica usa planilhas e sistema consultorio.me com alimentação manual; a necessidade de importação não é literal, mas é coerente com a realidade de migração.	RF-52	Derivado - requisito de transição e implantação, não explicitado nas entrevistas.

7. Matriz de rastreabilidade dos requisitos não funcionais

Os RNF abaixo foram avaliados com o mesmo critério. Em geral, os itens de usabilidade, responsividade, disponibilidade contextual e multicanalidade têm forte respaldo nas entrevistas, enquanto criptografia, backup e compatibilidade são mais claramente derivados do desenho de produto e das obrigações regulatórias.

7.1 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RNF-01	Alta	A interface deve ser intuitiva e permitir autoagendamento sem orientação externa.	DOC-02: uso precisa ser “leve, rápido, sem neura”; autoagendamento é valor central; DOC-01: profissional deve apenas alimentar dados em prontuários prontos.	OBJ-06; RNF-01	Explícito - fortemente sustentado pela fala da usuária final.
RNF-02	Alta	O sistema deve funcionar corretamente em smartphone e desktop, com prioridade de experiência mobile.	DOC-02: uso principal será pelo celular entre sessões; desktop fica para cadastro e relatórios.	RNF-02	Explícito - requisito textual da Entrevista 2.
RNF-03	Alta	O serviço deve estar disponível continuamente para suportar agendamentos fora do horário comercial.	DOC-02: pacientes procuram agendamento em horários inoportunos; DOC-01: agente deve responder e agendar automaticamente. O percentual de 99% não é textual.	OBJ-06; RNF-03	Consolidado - disponibilidade é explícita pelo contexto; meta de uptime é derivação técnica do EOR.
RNF-04	Alta	Tratar dados pessoais e clínicos em conformidade com a LGPD, com controle de acesso e proteção de dados.	DOC-01: lida com prontuários, laudos e dados financeiros; DOC-03 explicita a necessidade de conformidade regulatória para dados sensíveis.	OBJ-09; REST-01; RNF-04	Consolidado - requisito normativo claramente assumido pelo EOR.
RNF-05	Alta	Armazenar dados sensíveis com criptografia adequada.	Não textual nas entrevistas; decorre da necessidade de proteger prontuários, laudos e dados financeiros sensíveis.	RNF-04, RNF-05	Derivado - exigência técnica para suportar o requisito regulatório.

Código	Pri.	Requisito consolidado	Origem nos insumos (DOC-01/DOC-02)	Consolidação no EOR	Classificação / observação
RNF-06	Média	Responder operações comuns em até 3 segundos em condições normais de uso.	DOC-02: a usuária precisa consultar agenda rapidamente entre sessões e não quer depender de notebook; o limite de 3 segundos é uma meta técnica do EOR.	RNF-06	Consolidado - necessidade de rapidez é explícita, meta numérica é derivada.
RNF-07	Média	Suportar crescimento de usuários, salas e volume de dados sem degradação significativa.	DOC-01: visão de crescimento com mais salas, atendimentos e pacientes; DOC-02: múltiplos usuários seriam úteis no futuro.	Escopo 1.2; RNF-07	Explícito - requisito de evolução claramente sustentado pelos contextos futuros relatados.
RNF-08	Média	Ser compatível com os principais navegadores atuais.	Não aparece nas entrevistas; decorre da decisão de entregar o produto como aplicação web/SaaS.	REST-05; RNF-08	Derivado - requisito de plataforma para garantir acesso web amplo.
RNF-09	Alta	Tornar toda ação relevante rastreável por usuário, data e hora.	DOC-02: necessidade de comprovar hora do cancelamento; DOC-01: importância de rastrear presença, edição e liberação de laudos.	OBJ-09; RF-48; RNF-09	Consolidado - requisito transversal de auditoria.
RNF-10	Alta	Executar backup automático diário com possibilidade de restauração.	Não textual nas entrevistas; deriva da criticidade dos dados clínicos, financeiros e operacionais.	RNF-10	Derivado - requisito de continuidade e segurança operacional.
RNF-11	Alta	Suportar comunicação multicanal com ênfase em WhatsApp e e-mail.	DOC-01: canais desejados incluem WhatsApp, Instagram e e-mail; DOC-02: lembretes por WhatsApp/e-mail são valorizados.	OBJ-02, OBJ-10; RNF-11	Explícito - canais aparecem diretamente nos insumos.

8. Análise conclusiva

- O EOR está fortemente aderente às dores e objetivos operacionais levantados nas entrevistas, sobretudo nas frentes de agendamento, comunicação, financeiro e prontuário.
- A Entrevista 1 sustenta a maior parte das regras de negócio da clínica multidisciplinar; a Entrevista 2 qualifica a experiência de uso para profissionais autônomos e o uso mobile.
- Os requisitos classificados como derivados não são inconsistentes; eles representam maturação técnica do produto. Ainda assim, devem ser validados formalmente na próxima revisão com os stakeholders.
- RF-31 merece validação imediata, pois a política de cancelamento varia entre os perfis analisados e impacta diretamente cobrança, comunicação e reputação da clínica.
- RF-46, RNF-04, RNF-05, RNF-09 e RNF-10 devem ser tratados como baseline de conformidade e governança, dado o contexto de dados clínicos sensíveis.

9. Recomendações de uso da matriz

- Usar este documento como insumo para revisão do backlog, definição de MVP e preparação da próxima rodada de validação com gestora, secretaria e profissional autônomo.
- Transformar os requisitos derivados em itens explícitos de decisão, registrando aprovação, rejeição ou ajuste de formulação pelos stakeholders.
- Desdobrar a matriz em critérios de aceite e casos de teste, especialmente para regras críticas: conflitos de agenda, cancelamento tardio, inadimplência, bloqueio de laudo e trilha de auditoria.
- Versionar esta matriz em paralelo ao EOR para manter coerência entre fonte de origem, consolidação analítica e implementação do produto.

10. Referências documentais utilizadas

- DOC-01 - Transcrição da Entrevista 1 (Clínica Espaço Terapêutico).
- DOC-02 - Entrevista de Levantamento de Requisitos com Marla Gonçalves.
- DOC-03 - Especificação de Objetivos e Requisitos (EOR) - Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia, versão 1.0.